Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível da Comarca de Pelotas

Avenida Ferreira Viana, 1134 - Bairro: Areal - CEP: 96085000 - Fone: (53)3026-8500 - Balcão Virtual WhatsApp (53) 99705-0690 - Email: frpelotas5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5029275-41.2024.8.21.0022/RS

AUTOR: ANDREW SILVA DE AZEVEDO

RÉU: UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

RÉU: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

SENTENÇA

ANDREW SILVA DE AZEVEDO ajuizou a presente ação em face de **UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL**. Disse que possui diagnóstico de *neuromilite óptica (*CID G36.0), figurando como contratante de plano de saúde UNIMED. Alegou ter indicação médica para uso da medicação ROMOSOZUMABE (EVENITY), para tratamento da moléstia. Referiu que o fornecimento do medicamento foi negado pela parte ré, ao argumento de que *não preenche critério DUT de idade 70 anos.* Discorreu sobre os benefícios do fármaco para seu caso clínico concreto. Apontou urgência na concessão do medicamento. Teceu considerações jurídicas aplicáveis à espécie. Em sede de tutela de urgência, pediu fosse a parte ré instada a fornecer o medicamento ROMOSOZUMABE (EVENITY) de forma imediata. Requereu o julgamento de procedência da pretensão com a condenação da parte demandada ao fornecimento definitivo da medicação, prestando assistência médica correlata. Postulou a gratuidade judiciária. Juntou documentos.

Concedido o benefício da gratuidade judiciária e determinada a apresentação de emenda à inicial, diligência atendida.

Indeferida a tutela antecipada.

A parte autora acostou documentos diversos e reiterou o pedido de antecipação de tutela, o que foi indeferido.

Interposto agravo de instrumento, provido, com determinação de custeio do tratamento pela parte ré, ainda não transitado em julgado.

Citada, a corré UNIMED PELOTAS apresentou contestação. Preliminarmente, arguiu ilegitimidade passiva, discorrendo acerca da distinção entre as demandadas. No mérito, em síntese, disse desconhecer o teor da relação contratual mantida pela parte autora com a UNIMED NACIONAL, reiterando não ter vínculo negocial com o demandante. Negou ter participação nos fatos. Rogou pelo julgamento de improcedência da pretensão autoral. Juntou documentos.

Replicada a causa.

Aportou contestação pela corré UNIMED NACIONAL. Em preliminar, impugnou o valor atribuído à causa. No mérito, defendeu ser o contrato da parte autora porterior à Lei 9.656/98, revelando-se acertado o indeferimento de medicação ausente de cobertura no rol da ANS. Discorreu sobre a autonomia da vontade e os limites contratados. Afirmou estar a negativa amparada em Resolução Normativa da ANS. Prosseguiu afirmando que a medicação requerida não consta das previsões da Diretriz de Utilização, inclusive em conformidade à bula do próprio remédio. Rechaçou a hipótese de abalo moral. Rogou pelo julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Juntou documentos.

Sobreveio nova réplica.

Em decisão saneadora, rejeitadas as preliminares arguidas por ambos os corréus. Invertido o ônus da prova. Instadas acerca do interesse na dilação probatória, a parte demandante requereu o julgamento antecipado da lide.

Intimada a parte demandada a cumprir a tutela de urgência deferida pelo TJRS.

Manifestou-se a corré UNIMED NACIONAL noticiando a emissão de guia de autorização do medicamento, pleiteando, ainda, a *consulta ao NATJus e/ou consulta ao banco de dados pertinente,* o que foi indeferido pelo juízo.

Acostados documentos complementares pela parte demandada, acerca dos quais foi a parte autora intimada, manifestando-se.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o breve relatório. DECIDO.

1. PRELIMINARMENTE

1.1 Do Agravo de Instrumento

Pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte demandada em face da decisão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela requerente, deferindo-se a tutela antecipada.

Contudo, considerando que o presente julgamento ostenta natureza de juízo de cognição exauriente, a pendência do julgamento dos embargos não impede o julgamento do feito.

2. DO MÉRITO

A lide gira em torno do dever da parte ré de fornecer o medicamento EVENITY (ROMOSOZUMABE), prescrito para *neuromilite óptica* (CID10 G36.0).

A partir da contestação protocolizada pela parte demandada, verifica-se que o cerne da negativa administrativa, repisada judicialmente, corresponde à exclusão contratual para fornecimento de medicamentos em dissonância aos critérios estabelecidos pela Diretriz de Utilização.

De imediato, ressalto que a Lei nº. 9.961/2000, que cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar, estabelece no inc. III do art. 4º que compete à ANS elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei nº. 9.656/1998 e suas excepcionalidades.

Diante da previsão legal, a ANS estabelece uma lista de tratamentos, denominada Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que as operadoras de plano de saúde são obrigadas a fornecer, os quais, atualmente, estão especificados na Resolução nº. 465/2021.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº. 1.886.929 e 1.889.704, definiu que o rol da agência reguladora é, em regra, taxativo. Contudo, após a decisão, a questão foi discutida no Congresso Nacional, culminando a aprovação e a sanção da Lei nº. 14.454/2022, cuja redação acrescentou o § 13º no art. 10 da Lei nº. 9.656/1998, sendo estabelecidos critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos na lista da ANS:

> *Art. 10. [...]*
>
> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:* ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***
>
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou* ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.* ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***

Logo, diante da inclusão do § 13º do art. 10 da Lei nº. 9.656/1998, *os tratamentos indicados no rol da ANS não são taxativos*, tampouco representam exclusão tácita da cobertura contratual, sendo a sua finalidade apenas estabelecer garantia de cobertura mínima a ser prestada pelas seguradoras.

Para além disso, no curso do processo não foram produzidas provas outras que modificassem o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido liminar pelo TJRS (processo 5278331-77.2024.8.21.7000/TJRS, evento 4, DESPADEC1 e processo 5278331-77.2024.8.21.7000/TJRS, evento 57, RELVOTO1), que ora repiso:

> *Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma do que dispõe o art. 300, do CPC.*
>
> *In casu,* ***vislumbro os requisitos autorizativos a amparar a insurgência recursal****.*
>
> *De plano, observo que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de* ***Proteção*** *e Defesa do Consumidor, pois envolvem típica relação de consumo. Este é o entendimento da Súmula 608 do STJ, veja-se:*
>
> *Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.(Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)*
>
> *Portanto,* ***as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor****, incidindo o disposto no art. 51, IV, § 1°, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas abusivas.*
>
> *Aliás, os contratos de plano de saúde são tidos como de trato sucessivo. Assim, mesmo que a avença em tela tenha sido pactuada antes da vigência da Lei n. 9.656/1998,* ***aplicam-se, à espécie, as normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor,*** *conforme lição de Daniela Batalha Trettel:*
>
> > *O Código de Defesa do Consumidor foi um divisor de águas na defesa do usuário de planos de saúde diante das práticas restritivas de direito das operadoras de planos de saúde. Em vigor a nova lei, começou o debate acerca da sua aplicabilidade aos contratos anteriores a ela. Contratos anteriores à vigência do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça entende que o contrato de plano de saúde é contrato de trato sucessivo, caracterizado pela prestação continuada no tempo, sendo o Código de Defesa do Consumidor aplicável aos fatos que ocorreram após a sua entrada em vigor. 'a questão fundamental a ser dirimida é sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando que o contrato é anterior. Mas, na minha compreensão, esta terceira turma já decidiu eu nos contratos de execução continuada incide o Código de Defesa do Consumidor (Resp nº 331.860/RJ, DJ de 5/8/02), não sendo os fatos narrados anteriores a sua vigência (...) No mesmo sentido ainda os Recursos Especiais 244.847/SP, julgamento em 19/5/05, relator Ministro Pádua Ribeiro; 735.168/RJ e 986.947/RN, ambos julgados em 11/3/08 e relatados pela Ministra Nancy Andrighi (2010, p. 99)*
>
> *A própria natureza dos planos de saúde faz com que os consumidores os busquem visando segurança, previsibilidade e proteção contra eventuais problemas futuros, colocando o segurado em situação de evidente vulnerabilidade perante os fornecedores desses serviços de saúde.*
>
> *A importância destes valores objetivados na relação contratual foi acentuada pela doutrina de Cláudia Lima Marques:*

O objetivo principal destes contratos é a transferência (onerosa e contratual) de riscos referentes a futura necessidade de assistência médica ou hospitalar. A efetiva cobertura(reembolso no caso dos seguros de reembolso) dos riscos futuros à sua saúde e de seus dependentes, a adequada prestação direta ou indireta dos serviços de assistência médica (no caso dos seguros de pré-pagamento ou de planos de saúde semelhantes) é o que objetivam os consumidores que contratam com estas empresas. Para atingir este objetivo os consumidores manterão relações de convivência e dependência com os fornecedores desses serviços de saúde, por anos, pagando mensalmente suas contribuições, seguindo as instruções (por vezes exigentes e burocráticas) regulamentadoras dos fornecedores, usufruindo ou não dos serviços, a depender da ocorrência ou não do evento danoso à saúde do consumidor e seus dependentes (consumidores-equiparados) (1999, p. 192)

Nesse viés, sabe-se que a Lei 14.454/22, ao alterar a Lei 9.656/98, definiu que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui referência básica para as operadoras de assistência à saúde.

*Portanto, **não cabe aos planos de saúde limitar o tipo de tratamento que será prescrito ou a forma como deve ser realizada uma cirurgia**, incumbência que pertence ao profissional da medicina, detentor do conhecimento necessário para melhor conduzir o tratamento de seus pacientes, sobretudo pela prevalência do direito à saúde em conflito com demais interesses.*

***Na hipótese dos autos**, o autor é beneficiário do plano coletivo empresarial da ré, na segmentação ambulatorial + hospitalar c/ obstetrícia (1.6).*

*É portador de neuromielite óptica e osteoporose induzida por corticoterapia, sendo que para tais diagnósticos o médico assistente prescreveu o uso do fármaco **Romosozumabe**, visto que o paciente não apresentou resposta ao uso de bifosfonatos. Segundo o médico, o uso do medicamento previne o risco de novas fraturas e de necessidade de intervenção cirúrgica.*

Quanto ao tratamento em questão, além de ser procedimento incorporado às coberturas mínimas, nos termos da Lei n. 9.656/1998, artigo 12, incisos I, alínea 'b', visto ser realizado em ambiente ambulatorial, se trata de procedimento de cobertura obrigatória no tipo de plano do beneficiário:

Procedimento selecionado:

TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA, INTRAMUSCULAR OU SUBCUTÂNEA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)

Este procedimento é de cobertura obrigatória no tipo de plano informado.

*Portanto, **o não preenchimento dos requisitos da DUT (diretriz de utilização) do medicamento não afasta o dever de cobertura**.*

Assim se posiciona esta Corte:

> *APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARCINOMA MAMÁRIO. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MEDICAMENTO CONSTA NO ROL DA ANS. FLEXIBILIZAÇÃO DO DUT. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora objetiva a condenação da demandada ao fornecimento do medicamento medicamento LYNPARZA (OLAPARIBE) 150MG, indicando tomar 02 cápsulas (300MG) da medicação, via oral, 2 vezes ao dia e contínuo por 02 anos, julgada procedente na origem. Compete a ANS (art.4º), dentre outras diretrizes, elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirá referência básica de assistência (inc.III), com o escopo de garantir um plano de saúde e assistência mínimo de caráter privado, atento às evoluções tecnológicas, sem prejuízo da faculdade da contratação de cobertura mais extensa. Considerando que na data de 30 de agosto de 2022 houve a a inclusão do inibidor da PARP Olaparibe para o tratamento do câncer de ovário como cobertura obrigatória no âmbito da saúde suplementar, entendo que a cobertura do medicamento, no caso em concreto é de cobertura obrigatória. **Isso porque o medicamento consta do Rol da ANS, em que pese para doença diversa (câncer de Ovário), o médico assistente é quem decidirá se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações de uso daquele específico tratamento, tornando inviável que a demandada se negue a cobrir o tratamento previsto no rol da ANS, sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações de utilização do medicamento (Diretrizes de Utilização - DUT) o, considerando que representaria inegável ingerência na ciência médica, em prejuízo do paciente enfermo.**No caso dos autos, sendo a autora portadora de carcinoma mamário, necessita, segundo laudo médico, de tratamento com medicamento antineoplásico, de modo que a negativa de cobertura pela requerida se mostra abusiva.APELAÇÃO DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 50021185020208210017, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-08-2024)*
>
> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. MEDICAMENTO OCRELIZUMABE. APLICAÇÃO HOSPITALAR. ROL DA ANS. RECUSA DE FORNECIMENTO INDEVIDA. PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEVEM ESTAR PRESENTES OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 300 CPC, QUAIS SEJAM, A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NO CASO, A PARTE AUTORA FOI DIAGNOSTICADA COM ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA (CID 10 G35), NECESSITANDO DE TRATAMENTO COM APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO OCRELIZUMABE. NÃO SE TRATA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR, DIANTE DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTRAVENOSA. **OUTROSSIM, É ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA QUE A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA "DUT 65" (DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NA SAÚDE SUPLEMENTAR) NÃO AFASTA O DEVER DO PLANO DE SAÚDE DE FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE, SOBRETUDO QUANDO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.** DECISÃO MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 50287663120248217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 25-04-2024)*

*Dito isso, **é caso de ser deferida a antecipação de tutela recursal** para obrigar a ré a custear o tratamento prescrito com o medicamento Romosozumabe, nos termos do laudo médico, no prazo de 48h, sob pena de bloqueio de valores.*

Para além disso, conforme evidencia a documentação anexada pela parte autora, sobretudo aquela de evento 13, ATESTMED2, os fundamentos clínicos para utilização do fármaco para tratamento da moléstia que acomete a parte requerente foram devidamente minuciados:

Relatório Médico

Paciente Andrew Silva de Azevedo em tratamento para Neuromilite Óptica (G36.0) tendo recebido 60 pulsos de metilprednisolona em 2022 a 2023, atualmente em uso de Rituximabe.

Evoluindo com perda de altura, de aproimadamente 5 cm, com investigação mostrando fraturas de ao menos 2 vértebras dorsais e 5 vértebras lombares em decorrência de osteoporose induzida por corticoterapia (M80.4).

Sem resposta ao uso de bisfosfonatos, solicito liberação de Romozozumabe por 12 meses (210mg ao mês). Paciente de altíssimo risco de fraturas vertebrais e não vertebrais (colo de fêmur), com osteoporose grave induzida por corticóide. O não tratamento acarreta o risco de novas fraturas, sendo que novas fraturas vertebrais irão lebar a necessidade de intervenção cirúrgica pelo aumento importante da cifose dorsar e lordose lombo-sacra. Além disso, em decorrência da neuromielite o pacinte apresenta desequilibrio com risco de quedas o que aumenta em muito o risco de fratura de colo de fêmur.

À disposição para esclareceimentos necessários.

Dr. Daniel Brito de Araujo
REUMATOLOGIA
CREMERS 26622

16.09.24

Inegavelmente a medicação é de ser considerada eficaz, sobretudo pois prescrita pelo médico assistente, acompanhada, ainda, de fundamentados laudos a evidenciar sua adequação ao caso concreto.

Assim, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Posto isso, CONFIRMO a tutela recursal outrora concedida pelo TJRS e, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR a parte requerida A PROMOVER A APLICAÇÃO do medicamento EVENITY (ROMOSOZUMABE) à parte autora, nos termos do laudo médico de evento 13, OUT3, em seu ambiente ambulatorial, bem como prestar toda a assistência médica correlata necessária ao procedimento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 30 (trinta) dias multa e conversão em perdas e danos correspondentes ao custeio do medicamento e sua aplicação.

Ante a sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado (IPCA) da causa (R$ 55.803,36), nos termos do §2º do art. 85 do CPC/2015, considerando o tempo de tramitação da demanda e o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Intimadas as partes.

Interposto apelo e/ou recurso adesivo, independentemente de comando judicial, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Apresentadas as contrarrazões ou certificada a sua não apresentação, remetam-se, de imediato, os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com as homenagens de estilo, nos termos do art. 1.010, § 3º do CPC, haja vista que não cabe ao juízo de 1º grau a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso.

Documento assinado eletronicamente por **RITA DE CASSIA MULLER, Juíza de Direito**, em 25/03/2025, às 16:46:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10079324492v2** e o código CRC **58ad8aca**.